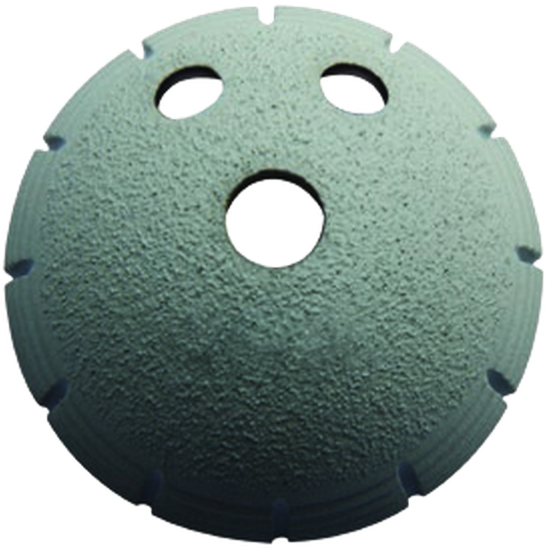
FICHA TÉCNICA

VERSAFITCUP CC TRIO

COTILO ACETABULAR SIN CEMENTAR

ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA



Cotilo VersaFitcup CC Trio.

VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA

PLATAFORMA COMPARTIDA

La familia VersaFitcup reúne cotilos press-fit con y sin orificios para tornillos y utiliza una instrumentación común. Junto con VersaFitcup CC Trio y VersaFitcup CC Trio No-Hole, el sistema incluye la opción de doble movilidad VersaFitcup DM.

VersaFitcup DM se presenta como alternativa a los pares de fricción cerámica-cerámica y a las cabezas de gran diámetro metal-metal. La documentación citada en la fuente describe resultados de desgaste, luxación y movilidad para esta solución de doble movilidad.



Configuración de doble movilidad VersaFitcup DM.

EVIDENCIA DESCRITA EN LA FUENTE

- Tasa de desgaste extremadamente baja documentada [2].
- Baja tasa de luxación comunicada para cotilos de doble movilidad [3].
- Aumento del rango de movilidad asociado al uso de cabezas femorales de mayor diámetro [4, 5].

APLICACIÓN DOCUMENTADA

Las referencias incluidas corresponden a artroplastia total de cadera (ATC). La combinación de cotilo, inserto y cabeza femoral debe respetar la compatibilidad dimensional indicada para el sistema.

FAMILIA CC TRIO

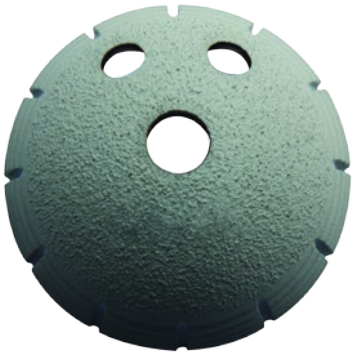
VersaFitcup CC Trio es un sistema de cotilo acetabular integrado en la familia VersaFitcup. La familia CC Trio comprende las configuraciones VersaFitcup CC Trio y VersaFitcup CC Trio No-Hole.

El sistema se basa en un cotilo elíptico press-fit y dispone de opciones con y sin orificios laterales para tornillos. Sus componentes comparten la instrumentación de la familia VersaFitcup.

FAMILIA Y OPCIONES

CC TRIO

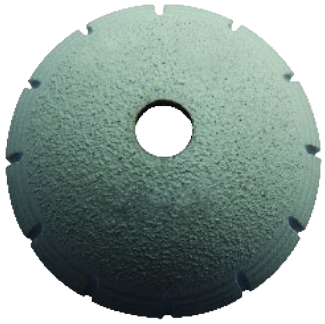
VersaFitcup CC Trio conserva las características externas de la familia y adapta la geometría interna para alojar cabezas de mayor diámetro. El cotilo incorpora orificios laterales que permiten complementar la fijación.



VersaFitcup CC Trio con orificios laterales para tornillos.

CC TRIO NO-HOLE

VersaFitcup CC Trio No-Hole comparte con CC Trio la geometría, el material, los recubrimientos y el acoplamiento del inserto, pero no presenta orificios laterales para tornillos.



VersaFitcup CC Trio No-Hole sin orificios laterales.

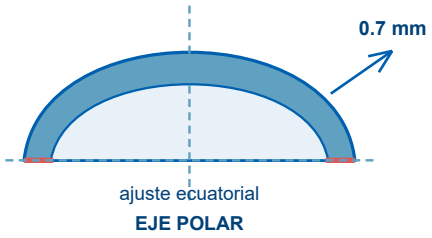
OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

- CC Trio: orificios laterales para fijación adicional con tornillos para hueso esponjoso de cabeza plana.
- CC Trio No-Hole: misma interfaz de inserto, sin orificios laterales.
- Insertos disponibles en UHMWPE, Highcross de UHMWPE altamente reticulado y cerámica BIOLOX delta.
- Versiones de polietileno planas y con realce de 10°.

DISEÑO Y ESTABILIDAD

El diseño press-fit elíptico proporciona ajuste en la región ecuatorial y contribuye a la estabilidad primaria. Las macroestructuras ecuatoriales son estrías circulares de retención de 0.7 mm de diámetro; según la fuente, aumentan entre 30 y 40% el contacto entre el implante y el hueso.

PRESS-FIT ELÍPTICO



Geometría elíptica, aplanamiento polar y ajuste ecuatorial.

REALCE DE 5°

El realce superior de 5° (5 grados) aporta cobertura adicional con finalidad antiluxante, también con un par cerámico, y puede disminuir el riesgo de carga sobre el borde.



Relación entre el realce y las cabezas femorales de mayor diámetro.

ESTABILIDAD Y MOVILIDAD

Las publicaciones citadas describen el uso de cabezas de mayor diámetro para ampliar el rango de movilidad y favorecer la estabilidad. Con inserto cerámico puede utilizarse una cabeza femoral de 36 mm desde el cotilo tamaño 50 y una de 40 mm desde el tamaño 56.

VALORES DOCUMENTADOS

30-40%

más contacto implante-hueso

36 mm

desde cotilo tamaño 50

40 mm

desde cotilo tamaño 56

FIJACIÓN Y MATERIALES

TRANSFERENCIA DE CARGA

La forma elíptica con aplanamiento polar favorece una transferencia gradual de carga, reduce los picos de tensión y contribuye a la estabilidad primaria. El espesor del cotilo está configurado para admitir cabezas de gran diámetro y limitar el riesgo de deformación durante la impactación.



Detalle del mecanismo de bloqueo entre inserto y cotilo.

FIJACIÓN Y BLOQUEO

- El mecanismo de bloqueo de los insertos UHMWPE utiliza un sistema de encastre fuera de la zona ecuatorial de carga y frente a la región de mayor espesor del inserto. Esta disposición reduce las tensiones en la interfaz inserto-cotilo y puede disminuir el riesgo de fractura del borde del inserto ante contacto mecánico.
- La corona dentada múltiple limita la rotación y los micromovimientos y reduce el desgaste de la superficie posterior.
- Los tornillos para hueso esponjoso son de aleación de titanio, tienen cabeza plana, diámetro de 6.5 mm y longitudes de 20 a 45 mm.
- CC Trio y CC Trio No-Hole admiten un tapón metálico para cerrar el orificio central.

MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS

Los cotilos CC Trio y CC Trio No-Hole son de aleación de titanio-vanadio. El tratamiento superficial combina recubrimiento de Ti de 100 µm y recubrimiento de HA (hidroxiapatita) de 90 µm. Los insertos están disponibles en cerámica BIOLOX delta de CeramTec, UHMWPE y Highcross.

CONFIGURACIONES DE INSERTO

Los insertos de polietileno se ofrecen en UHMWPE y Highcross (UHMWPE altamente reticulado), en versiones plana y con realce de 10°. La disponibilidad depende del diámetro de cabeza y del tamaño del cotilo.

6.5 mm

diámetro de tornillo

20 a 45 mm

longitudes disponibles

Ti 100 µm + HA 90 µm

tratamiento superficial

GAMA DE PRODUCTO

La tabla relaciona el tipo de inserto y el diámetro de cabeza con cada tamaño de cotilo acetabular. Los códigos AZ, B, C, E, F y G identifican las compatibilidades del sistema. Una celda vacía indica que la combinación no figura en la gama documentada.

Compatibilidad por inserto, cabeza y tamaño de cotilo

GRUPO 1 | UHMWPE Y CERÁMICA

Inserto	Cabeza (mm)	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
UHMWPE plano	22	AZ*											
UHMWPE plano	28		B**	C	C	E	E	E	F	F	F	G	G
UHMWPE plano	32					E	E	E	F	F	F	G	G
UHMWPE con realce	22	AZ*											
UHMWPE con realce	28		B**	C	C	E	E	E	F	F	F	G	G
UHMWPE con realce	32					E	E	E	F	F	F	G	G
Cerámico BIOLOX delta	28		B**	C	C	E	E	E	F	F	F	G	G
Cerámico BIOLOX delta	32			C	C	E	E	E	F	F	F	G	G
Cerámico BIOLOX delta	36					E	E	E	F	F	F	G	G

GRUPO 2 | CERÁMICA Y HIGHCROSS

Inserto	Cabeza (mm)	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Cerámico BIOLOX delta	40								F	F	F	G	G
Highcross plano	22	AZ*											
Highcross plano	28		B**	C	C	E	E	E	F	F	F	G	G
Highcross plano	32			C	C	E	E	E	F	F	F	G	G
Highcross plano	36					E	E	E	F	F	F	G	G
Highcross con realce	22	AZ*											
Highcross con realce	28		B**	C	C	E	E	E	F	F	F	G	G
Highcross con realce	32					E	E	E	F	F	F	G	G

DISPONIBILIDAD

** El tamaño 42 está disponible bajo pedido únicamente para VersaFitcup CC Trio.*
*** El tamaño 44 está disponible bajo pedido.*

ABORDAJE ANTERIOR MÍNIMAMENTE INVASIVO

El abordaje anterior mínimamente invasivo para artroplastia de cadera. El acceso sigue una trayectoria intermuscular e internerviosa orientada a preservar las estructuras periarticulares, incluidos músculos, tendones, vasos y nervios.



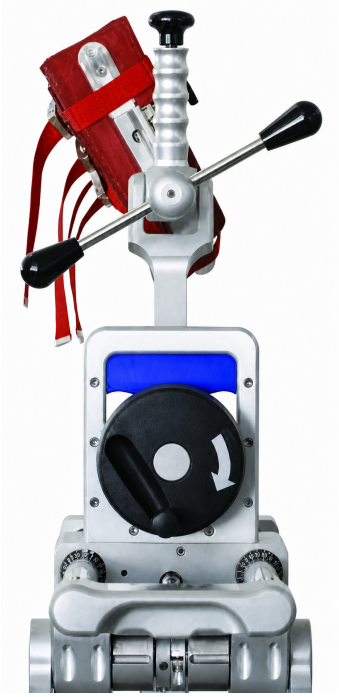
Contexto quirúrgico general para el abordaje anterior.

PRINCIPIOS DEL ABORDAJE

- Trayectoria anterior intermuscular e internerviosa.
- Instrumental específico para las etapas del abordaje.
- Posicionador móvil de miembro inferior integrado a la instrumentación.

POSICIONAMIENTO DEL MIEMBRO INFERIOR

El posicionador permite controlar la tracción, la aducción y la hiperextensión durante la intervención. Su uso forma parte de la técnica y de la instrumentación específica del abordaje.



Posicionador móvil de miembro inferior.

CONTROL POSICIONAL

01 TRACCIÓN

02 ADUCCIÓN

03 HIPEREXTENSIÓN

REFERENCIAS

REFERENCIAS 1-4

1. Müller DA, Zingg P, Dora C. 5 year survival and radiological outcome of minimally invasive total hip replacements using a relatively new implant (Quadra®/Versafitcup). SGO 2011, 22th-24th June, Lausanne.

2. Bernardoni M, Siccardi F, Quagliana I, Spadini E. Analysis of Versafitcup Double Mobility Wear Rates. M.O.R.E. Journal, May 2011; Vol. 1: 3-7.

3. Leclercq S, El Blidi S, Aubriot JH. Treatment of recurrent dislocation of Total Hip Replacement using Bousquet type double mobility cup. Review of 13 cases. Revue de Chirurgie Orthopédique, 81: 389-394. Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHR Côte de Nacre, Caen, France.

4. Adam P, Farizon F, Fessy MH. Dual articulation retentive acetabular liners and wear: surface analysis of 40 retrieved polyethylene implants. Rev Chir Orthop. 2005; 91: 627-636.

REFERENCIAS 5-8

5. Burroughs BR, Hallstrom B, Golladay GJ, Hoeffel D, Harris WH. Range of Motion and Stability in Total Hip Arthroplasty With 28-, 32-, 38-, and 44-mm Femoral Head Sizes - An In Vitro Study. J Arthroplasty. January 2005; 20(1): 11-9.

6. Camesasca S et al. Analysis of Versafitcup CC Trio acetabular shell deformation during impaction. M.O.R.E. Journal, May 2011; Vol. 1: 15-18.

7. Michael DR, MD. Review of the Evolution of the Cementless Acetabular Cup. ORTHOSuperSite, December 1, 2008.

8. Spadini E et al. Is backside wear a real issue in modern design cups? M.O.R.E. Journal, May 2011; Vol. 1: 12-14.

AVISO PROFESIONAL

Material destinado exclusivamente a profesionales de la salud. Esta ficha técnica no sustituye las instrucciones de uso vigentes ni la documentación técnica aplicable al producto.

Medacta International

DISTRIBUIDO POR

CHACO IMPLANTES
al servicio de la salud

CHACO IMPLANTES

Corrientes 781, Resistencia, Chaco (3500), Argentina

Tel.: 0362-4571854

chacoimplantes@gmail.com

Instagram: @chacoimplanteok

Distribuido por CHACO IMPLANTES

Material destinado exclusivamente a profesionales de la salud. Esta ficha técnica no sustituye las instrucciones de uso vigentes ni la documentación técnica aplicable al producto.

TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO

DOCUMENTO DE REFERENCIA: Versafitcup CC Trio Family Leaflet | Ref. 99.16TRIO.11 - Rev. 03

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: Marzo de 2014 | FABRICANTE: Medacta International